RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO · RIPOSTE À LA MALADIE À VIRUS EBOLA

Rapport épidémiologique national

Maladie à virus Ebola · situation au 10 oct. 2026

Période de rapportage
4 oct. – 10 oct. 2026
Semaine épidémiologique S41 · 2026
SitRep de référence : N° 148

Sources : SitRep SitRep_MVEBDB_148_09_10_2026.pdf · Linelist LINELIST_09102026.xlsx · lln LLN_export_oct.csv · contact tracing CONTACT-TRACING_09102026.xlsx. Données extraites le 10 oct. 2026. Rapport généré automatiquement — à valider par l'équipe de surveillance avant diffusion.

1. POINTS SAILLANTS

Tableau 1 : Cumul national depuis le début de l'épidémie (SitRep N° 148, publié le 10 oct. 2026)

Cas confirmés	Décès	Létalité	Guéris	En isolement / CTE	Suivi des contacts
8 914	4 315	48,4 %	2 338	946	83,1 %

Nouveaux cas des dernières 24 h : 69 ; nouveaux décès : 40. Létalité = décès / cas confirmés.

Tableau 2 : Période de rapportage du 4 oct. au 10 oct. 2026 (Linelist, date de notification)

Cas confirmés (7 j)	7 j précédents	Variation	Décès (7 j)	Létalité (7 j)	Alertes (7 j)
344	392	-12 %	119	34,6 %	5 856

Tableau 3 : Zones de santé selon la situation épidémiologique

Situation de la zone de santé	Définition	Zones	%
Rouge	Cas < 21 j et ≥ 1 critère d'aggravation (ou ≥ 2 critères de contexte)	43	20 %
Orange	Cas < 21 j, sans critère rouge	9	4 %
Jaune	Dernier cas il y a 22 à 42 jours	8	4 %
Verte	Plus de 42 jours sans cas	9	4 %
Non touchée	Aucun cas	146	68 %

Messages clés

- Du 4 oct. au 10 oct. 2026, **344 cas confirmés** et 119 décès ont été notifiés (létalité 34,6 %), contre 392 cas la semaine précédente : tendance **en baisse** (-12 %).
- Cumul officiel (SitRep N° 148 du 9 oct. 2026) : **8 914 cas confirmés**, 4 315 décès (létalité 48,4 %), 2 338 guéris et 946 patients en isolement/CTE.
- Le nombre de reproduction effectif consolidé est de **0,78** (IC 95 % 0,70–0,85) au 26 sept. 2026 ; probabilité que Rt > 1 : 0 %.
- 69 zones de santé ont été touchées : **43 en rouge** (hotspots), 9 en orange, 8 en jaune et 9 en vert (> 42 jours sans cas).
- 2 zones en priorité 1 (score ≥ 70) et 15 en priorité 2 (50–69) ; zones les plus prioritaires : Wamba (78), Mambasa (78), Mabalako (69), Musienene (67), Beni (64).
- Suivi des contacts : 1 011 contacts en suivi, **17,3 % vus** le 9 oct. 2026, 780 non vus depuis plus de 3 jours ; seuls **1,0 %** des nouveaux cas étaient connus comme contacts.

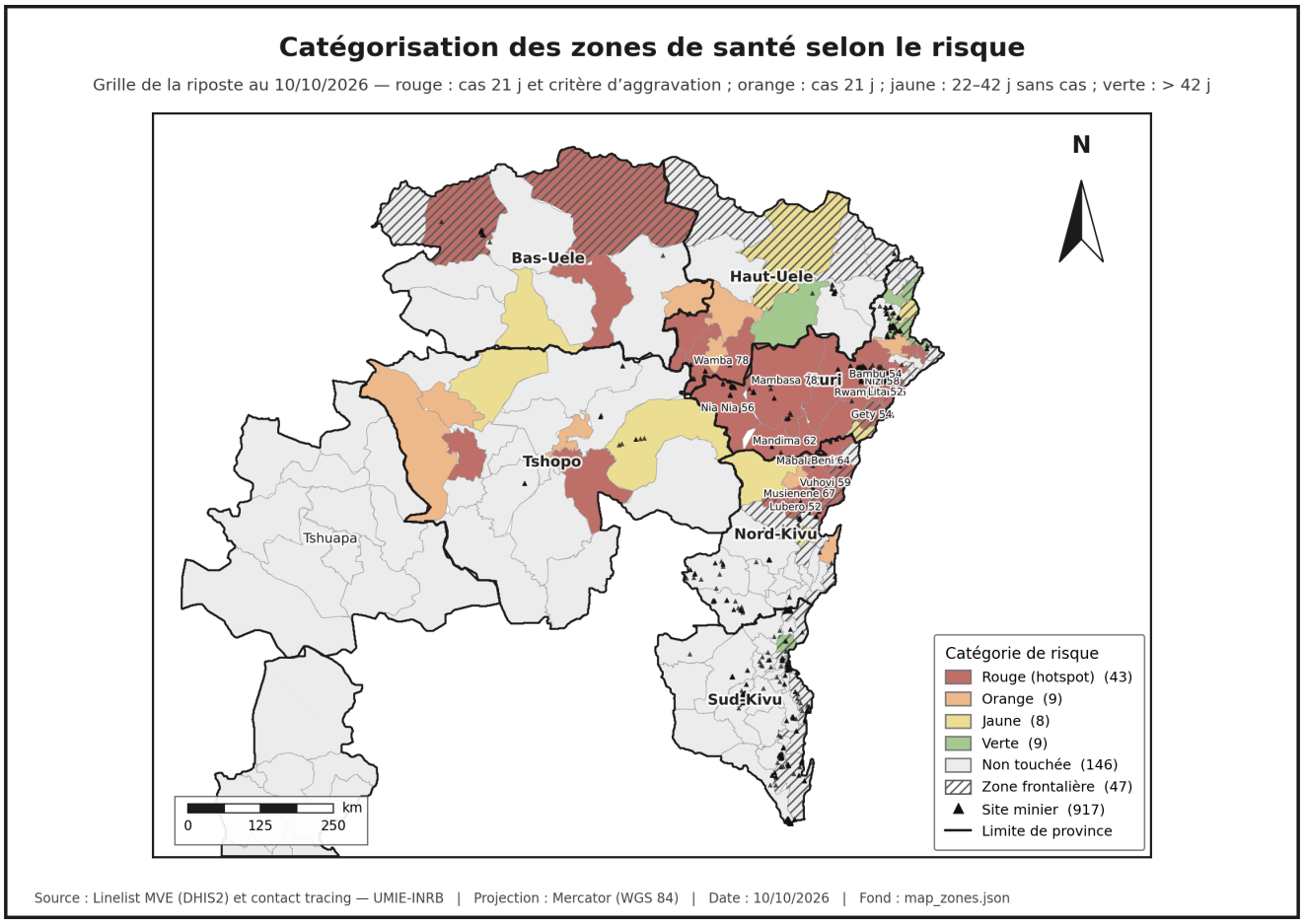


Figure 1 : situation épidémiologique des zones de santé au 10 oct. 2026 (catégories de risque).

2. CONTEXTE

L'épidémie de maladie à virus Ebola est en cours depuis le 3 mai 2026 (premier cas confirmé notifié dans la Linelist). Au 10 oct. 2026, 7 provinces ont notifié des cas : Ituri (6 609 cas, 28 zones touchées sur 36), Nord-Kivu (1 858 cas, 17 zones touchées sur 34), Haut-Uélé (372 cas, 7 zones touchées sur 13), Tshopo (57 cas, 7 zones touchées sur 23), Bas-Uélé (13 cas, 4 zones touchées sur 11), Sud-Kivu (3 cas, 1 zones touchées sur 34), Sud-Ubangi (2 cas, 1 zones touchées sur 16). Ce rapport combine les chiffres officiels du SitRep (cumuls), la Linelist des cas (analyse temps–lieu–personne), le Linelist des alertes (lln) et la base de suivi des contacts (transmission et riposte).

3. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET DE LABORATOIRE

3.1 Distribution dans le temps

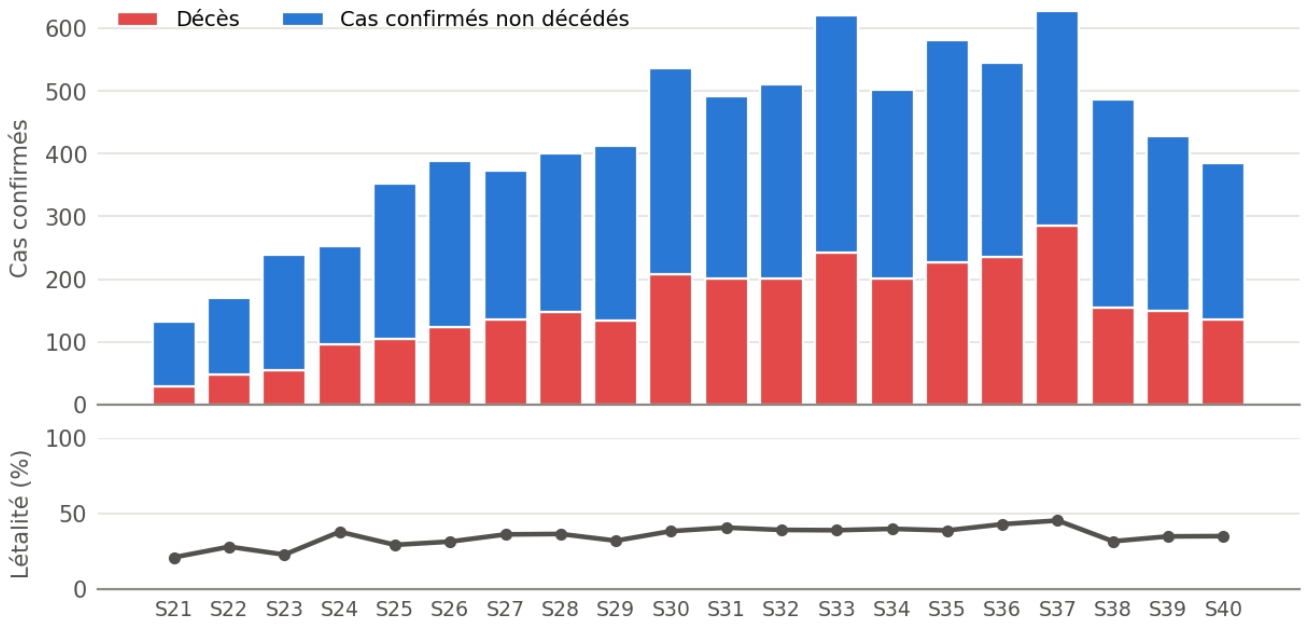


Figure 2 : courbe épidémique hebdomadaire des cas confirmés selon l'issue (semaine de notification, n = 8 442 sur 20 semaines ; semaine en cours exclue car incomplète) et létalité hebdomadaire (panneau inférieur).

Au cours de la dernière semaine complète (S40, du 28 sept. au 4 oct. 2026), 386 cas confirmés et 136 décès ont été notifiés (létalité 35,2 %). Le pic hebdomadaire de la période représentée a été atteint en S37 (628 cas).

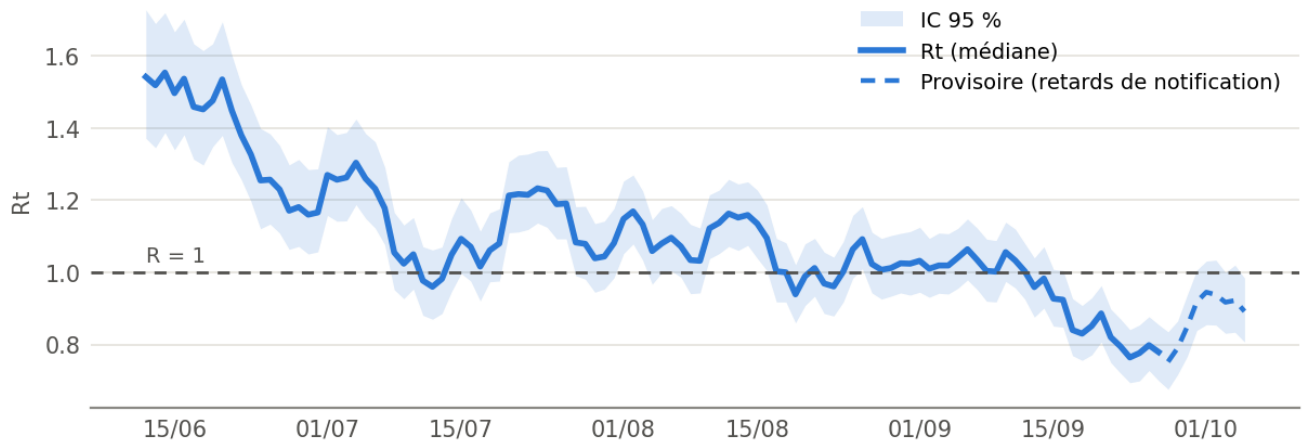


Figure 3 : nombre de reproduction effectif national (EpiEstim, fenêtre de 7 jours, intervalle sériel estimé sur les chaînes de transmission) sur les 120 derniers jours ; trait plein = estimation consolidée, pointillé = provisoire.

Le nombre de reproduction consolidé est de **0,78** (IC 95 % 0,70–0,85) au 26 sept. 2026. Le délai médian entre le début des symptômes et la notification est de 5 jours (90e centile 14 jours) : les cas des 2 dernières semaines sont encore incomplets, ce que corrige le nowcasting (probabilité de croissance : 0,0 %).

3.2 Confirmation au laboratoire

Tableau 4 : Tests de confirmation (RT-PCR) par laboratoire, cumul

Laboratoire	Tests valides	Positifs	Négatifs	Positivité (IC 95 %)
LPSP BUNIA	6 466	2 595	3 871	40,1 % (38,9–41,3)
INRB - Antenne Beni	2 537	1 029	1 508	40,6 % (38,7–42,5)
Labo Nizi	2 099	1 018	1 081	48,5 % (46,4–50,6)
Autres	1 899	838	1 061	44,1 % (41,9–46,4)
Labo Mongbwalu	1 509	677	832	44,9 % (42,4–47,4)
Labo Nyankunde	1 202	110	1 092	9,2 % (7,6–10,9)
Labo Komanda	985	247	738	25,1 % (22,5–27,9)
Non renseigné	972	340	632	35,0 % (32,0–38,0)
Autres (14 laboratoires)	4 629	1 926	2 703	41,6 %
Total	**22 298**	**8 780**	**13 518**	**39,4 %**

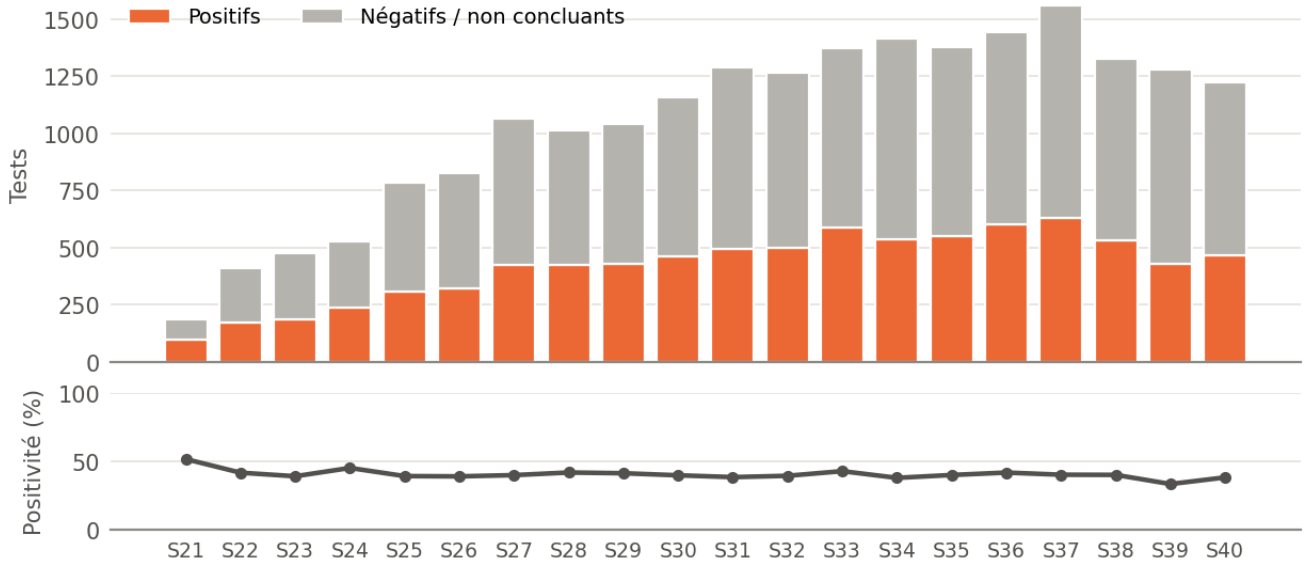


Figure 4 : tests réalisés par semaine selon le résultat (n = 21 040) et taux de positivité hebdomadaire (panneau inférieur).

En S40, 1 223 tests ont été réalisés, dont 468 positifs (positivité 38,3 %). Délai médian prélèvement → résultat : 0 jour(s).

3.3 Distribution géographique

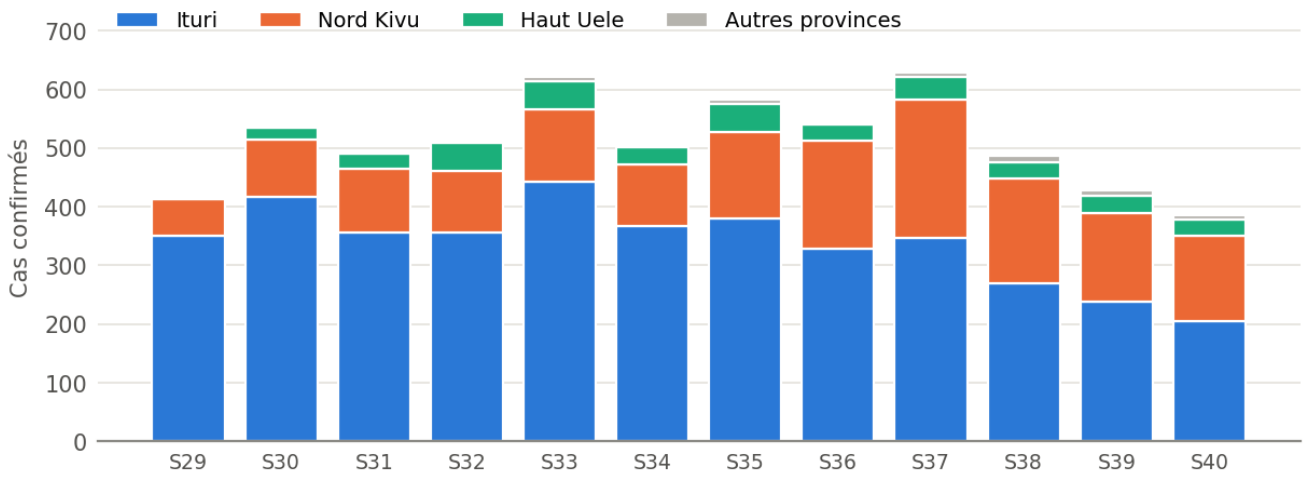


Figure 5 : cas confirmés par semaine de notification et par province (n = 6 132).

Tableau 5 : Cas confirmés, décès et suivi des contacts par province (Linelist ; zones et suivi : SitRep)

Province	Confirmés (cumul)	Décès conf.	Létalité	Confirmés 14 j	Zones touchées / total	Contacts actifs	Suivi contacts (SitRep)
Ituri	6 355	2 293	36,1 %	397	28 / 36	502	80,2 %
Nord Kivu	1 955	861	44,0 %	265	17 / 34	277	84,1 %
Haut Uele	392	59	15,1 %	54	7 / 13	229	90,5 %
Tshopo	59	8	13,6 %	15	7 / 23	3	91,0 %
Bas Uele	14	1	7,1 %	3	4 / 11	0	84,8 %
Sud Kivu	3	1	33,3 %	0	1 / 34	0	—
Sud Ubangi	2	0	0,0 %	2	1 / 16	0	—
Kasai	0	0	—	0	—	0	—
Kinshasa	0	0	—	0	—	0	—
Tshuapa	0	0	—	0	—	0	—
Total	**8 780**	**3 223**	**36,7 %**	**736**		**1 011**	**83,1 %**

Les cumuls de la Linelist peuvent différer légèrement du SitRep (délais de saisie, reclassements) ; voir la section 5.

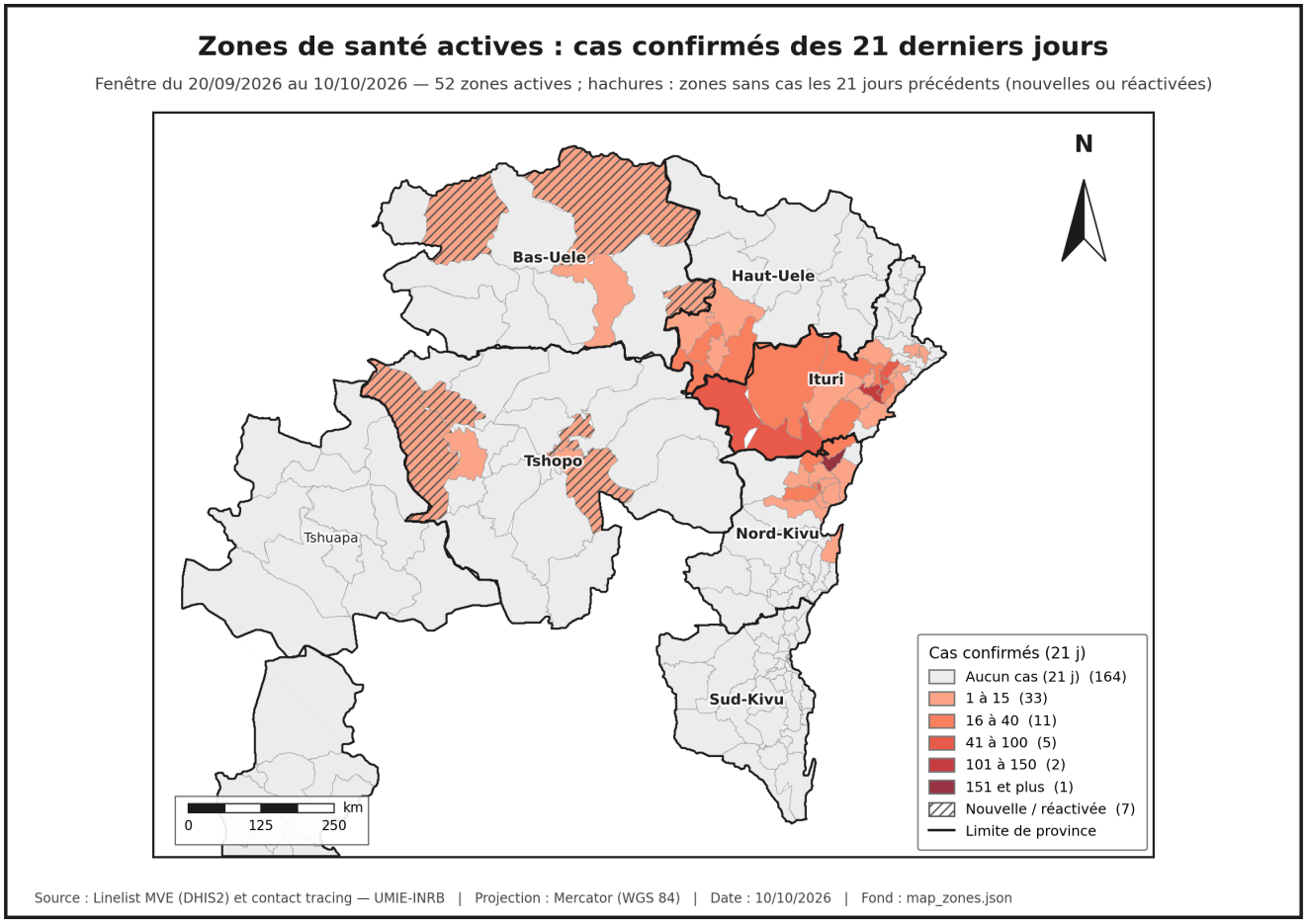


Figure 6 : zones de santé actives : cas confirmés des 21 derniers jours.

Tableau 6 : Les 15 zones de santé ayant notifié le plus de cas confirmés au cours des 14 derniers jours

Zone de santé	Province	Confirmés 14 j	14 j précédents	Variation	Décès 14 j	Létalité	Rt	Jours depuis le dernier cas
Beni	Nord Kivu	100	125	-20 %	55	55 %	1,02	1
Bunia	Ituri	88	96	-8 %	43	49 %	0,84	0
Katwa	Nord Kivu	70	87	-20 %	15	21 %	0,57	0
Rwampara	Ituri	68	91	-25 %	11	16 %	1,01	0
Nizi	Ituri	53	51	+4 %	18	34 %	0,84	0
Mandima	Ituri	52	33	+58 %	26	50 %	0,73	0
Nia Nia	Ituri	28	54	-48 %	12	43 %	0,93	0
Musienene	Nord Kivu	25	10	+150 %	7	28 %	1,11	1
Mangala	Ituri	24	62	-61 %	13	54 %	0,43	1
Wamba	Haut Uele	22	25	-12 %	7	32 %	1,12	0
Pawa	Haut Uele	22	19	+16 %	1	5 %	1,34	2
Butembo	Nord Kivu	20	30	-33 %	5	25 %	0,79	3
Mabalako	Nord Kivu	16	12	+33 %	3	19 %	2,44	0
Mambasa	Ituri	15	7	+114 %	10	67 %	2,19	2
Oicha	Nord Kivu	15	23	-35 %	5	33 %	0,87	1

3.4 Caractéristiques des cas (âge et sexe)

Tableau 7 : Cas confirmés et probables par groupe d'âge et sexe, décès et létalité (Linelist)

Groupe d'âge (ans)	Masculin	Féminin	Total	%	Décès	Létalité
0–4	659	573	1 233	14,2 %	800	64,9 %
5–14	439	449	888	10,2 %	311	35,0 %
15–24	559	977	1 536	17,7 %	464	30,2 %
25–34	861	953	1 814	20,9 %	531	29,3 %
35–44	691	749	1 440	16,6 %	410	28,5 %
45–59	581	562	1 143	13,1 %	352	30,8 %
≥ 60	286	357	643	7,4 %	291	45,3 %
Âge inconnu	53	60	113	—	70	—
Total	**4 129**	**4 680**	**8 810**	100 %	**3 229**	**36,7 %**

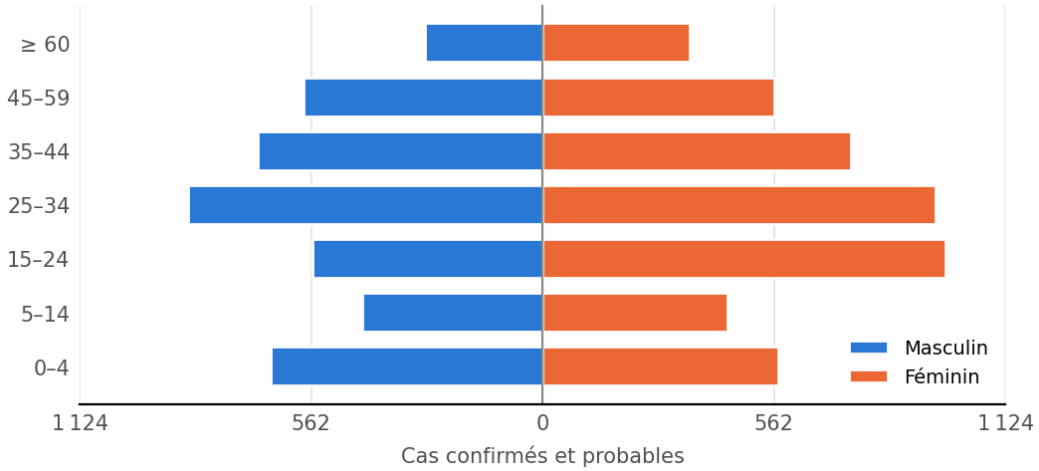


Figure 7 : pyramide des âges des cas confirmés et probables selon le sexe.

Les femmes représentent 53,1 % des cas. Les enfants de moins de 18 ans représentent 26,1 % des cas. 149 agents de santé (personnel de première ligne) ont été confirmés depuis le début de l'épidémie.

3.5 Transmission et suivi des contacts

Tableau 8 : Indicateurs de suivi des contacts et de transmission

Indicateur	Valeur	Commentaire
Contacts en cours de suivi	1 011	Journée de référence : 9 oct. 2026
Contacts vus (dernière journée)	17,3 %	Cible ≥ 90 %
Contacts non vus depuis > 3 jours	780	À rechercher en priorité (perdus de vue)
Suivi de 21 jours mené à terme	46,7 %	Parmi les contacts sortis du suivi
Nouveaux cas connus comme contacts	1,0 %	14 derniers jours ; cible ≥ 80 %
Nouveaux cas avec source identifiée	7,2 %	Liste de contacts ou investigation
Contacts listés par cas index (médiane)	9	266 cas index
Taux d'attaque secondaire	1,37 %	Contacts devenus cas / contacts listés
Chaînes de transmission reconstituées	280	47 actives sur 21 jours ; 3 générations au maximum
Intervalle sériel	13,4 j	Médiane 11,0 j (n = 405 paires)

La transmission est très hétérogène (paramètre de dispersion k = 0,23) : une minorité de cas génère la majorité des cas secondaires, ce qui justifie la recherche rétrograde de la source (traçage « en amont ») et le contrôle des événements de super-propagation (funérailles, soins).

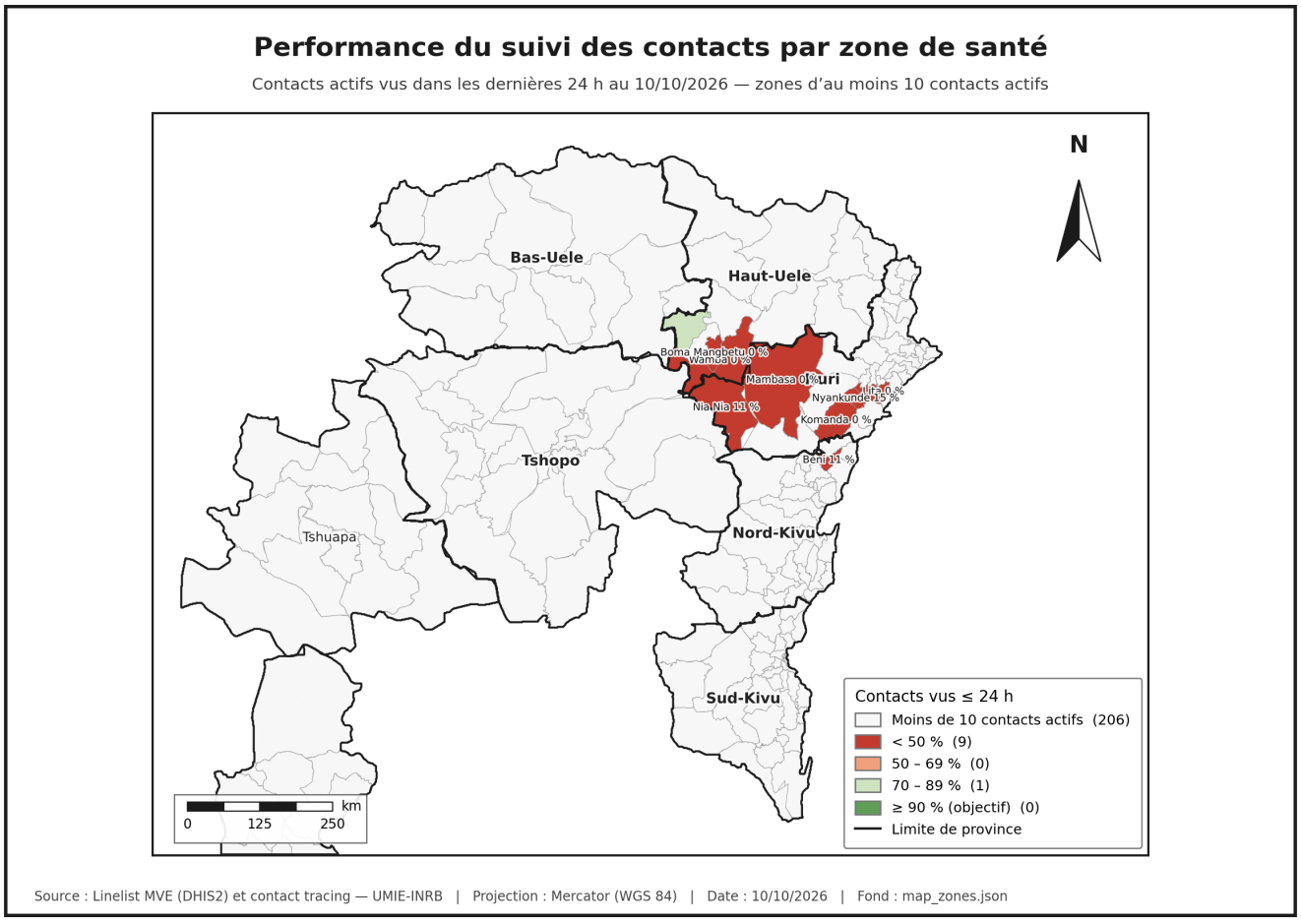


Figure 8 : suivi des contacts par zone de santé.

3.6 Zones à risque et priorités opérationnelles

Chaque zone touchée reçoit un score de risque de 0 à 100 combinant la dynamique (cas des 21 derniers jours, tendance, probabilité que Rt > 1), la gravité (décès communautaires positifs, décès groupés), le contexte (proximité d'une zone à forte incidence, frontière, sites miniers) et la performance de la riposte (contacts non vus, résurgence, EDS non réalisés). Priorité 1 : score ≥ 70 ; priorité 2 : 50–69 ; priorité 3 : 30–49.

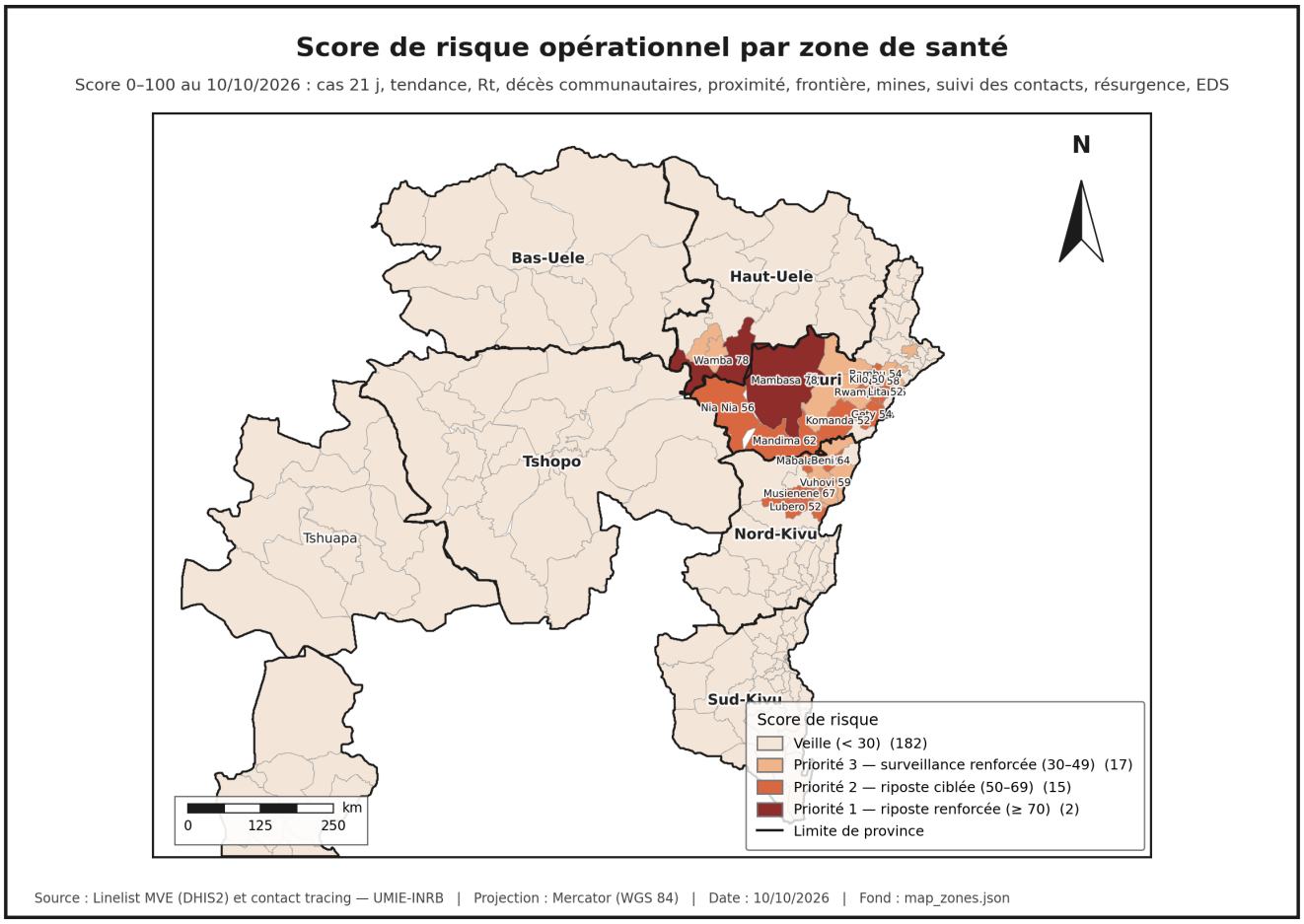


Figure 9 : score de risque opérationnel par zone de santé (zones de priorité 1 à 3 étiquetées).

Tableau 9 : Les 15 zones de santé les plus prioritaires selon le score de risque

Rang	Zone de santé	Province	Score	Priorité	Cas 21 j	Principaux facteurs
1	Wamba	Haut Uele	78	Priorité 1	37	cas des 21 derniers jours (14), tendance à la hausse (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10)
2	Mambasa	Ituri	78	Priorité 1	19	tendance à la hausse (12), cas des 21 derniers jours (12), P(Rt > 1) (12)
3	Mabalako	Nord Kivu	69	Priorité 2	23	cas des 21 derniers jours (13), tendance à la hausse (12), P(Rt > 1) (12)
4	Musienene	Nord Kivu	67	Priorité 2	27	cas des 21 derniers jours (13), tendance à la hausse (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10)
5	Beni	Nord Kivu	64	Priorité 2	157	cas des 21 derniers jours (20), proximité d'une zone à incidence élevée (10), décès communautaires positifs (8)
6	Mandima	Ituri	62	Priorité 2	81	cas des 21 derniers jours (17), tendance à la hausse (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10)
7	Vuhovi	Nord Kivu	59	Priorité 2	12	tendance à la hausse (12), cas des 21 derniers jours (10), proximité d'une zone à incidence élevée (10)
8	Nizi	Ituri	58	Priorité 2	80	cas des 21 derniers jours (17), proximité d'une zone à incidence élevée (10), décès communautaires positifs (8)
9	Rwampara	Ituri	56	Priorité 2	114	cas des 21 derniers jours (19), proximité d'une zone à incidence élevée (10), décès communautaires positifs (8)
10	Nia Nia	Ituri	56	Priorité 2	52	cas des 21 derniers jours (16), proximité d'une zone à incidence élevée (10), décès communautaires positifs (8)
11	Bambu	Ituri	54	Priorité 2	21	cas des 21 derniers jours (12), tendance à la hausse (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10)
12	Gety	Ituri	54	Priorité 2	4	tendance à la hausse (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10), décès communautaires positifs (8)
13	Lubero	Nord Kivu	52	Priorité 2	8	proximité d'une zone à incidence élevée (10), cas des 21 derniers jours (9), décès communautaires positifs (8)
14	Lita	Ituri	52	Priorité 2	22	cas des 21 derniers jours (12), tendance à la hausse (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10)
15	Komanda	Ituri	52	Priorité 2	27	cas des 21 derniers jours (13), proximité d'une zone à incidence élevée (10), décès communautaires positifs (8)

4. SUIVI DE LA PERFORMANCE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA RIPOSTE

Tableau 10 : Indicateurs de performance de la surveillance et de la riposte (national)

Indicateur	Dernière semaine	Moyenne 4 semaines	Cumul / global	Cible	Statut
Nouveaux cas confirmés connus comme contacts	1,3 %	2,4 %	1,0 %	≥ 80 %	Non atteinte
Nouveaux cas avec source identifiée	10,4 %	10,0 %	7,2 %	≥ 80 %	Non atteinte
Délai médian début des symptômes → notification	5,0 j	5,0 j	5,0 j	≤ 3 j	Non atteinte
Délai médian début des symptômes → isolement	5,0 j	4,8 j	4,0 j	≤ 3 j	Non atteinte
Contacts vus au cours des dernières 24 h	16,5 %	32,0 %	35,3 %	≥ 90 %	Non atteinte
Alertes investiguées en ≤ 24 h	98,9 %	98,5 %	98,2 %	≥ 80 %	Atteinte
Décès communautaires prélevés (alertes décès)	—	—	69,1 %	≥ 80 %	Non atteinte
Délai médian prélèvement → résultat	0,0 j	0,0 j	0,0 j	≤ 1 j	Atteinte

Cibles de référence modifiables dans config/parametres.json (clé « cibles_rapport »). Dernière semaine = dernière semaine épidémiologique complète (contacts vus : moyenne des 7 derniers jours).

6 indicateur(s) sur 8 n'atteignent pas la cible : nouveaux cas confirmés connus comme contacts; nouveaux cas avec source identifiée; délai médian début des symptômes → notification; délai médian début des symptômes → isolement; contacts vus au cours des dernières 24 h; décès communautaires prélevés (alertes décès).

Qualité des données : score global de conformité de 92,1 % sur 40 contrôles (complétude, cohérence, validité, unicité, actualité) ; le détail figure dans le menu « Qualité des données » du tableau de bord.

5. DÉFIS ET LACUNES

- **Transmission non détectée** : seuls 1,0 % des nouveaux cas étaient connus comme contacts et 7,2 % ont une source identifiée ; la majorité des chaînes échappe au listage.
- **Suivi des contacts insuffisant** : 17,3 % des contacts vus lors de la dernière journée (cible ≥ 90 %), 780 contacts non vus depuis plus de 3 jours.
- **Documentation des enterrements** : l'organisateur des funérailles n'est renseigné que pour 4,5 % des décès de la Linelist ; 187 enterrements non sécurisés documentés.
- **Isolement** : 6 392 cas confirmés sans admission enregistrée en CTE (72,8 %) — non-isolement réel ou admission non saisie, à vérifier par province.
- **Concordance SitRep – Linelist** : 8 914 cas au SitRep contre 8 780 dans la Linelist ; 54 zones présentent un écart.
- **Dénominateurs de population** absents : les taux d'incidence et d'attaque par zone ne peuvent pas être calculés (ajouter un fichier de population par zone de santé).

6. RECOMMANDATIONS ET ACTIONS PRIORITAIRES

- **Zones de priorité 1** (Wamba, Mambasa) : riposte renforcée — équipes d'intervention rapide, recherche active des cas, listage exhaustif et suivi quotidien des contacts, prélèvement et EDS de tous les décès communautaires.
- **Zones de priorité 2** (Mabalako, Musienene, Beni, Mandima, Vuhovi, Nizi, Rwampara, Nia Nia, Bambu, Gety…) : riposte ciblée sur les aires de santé actives et surveillance renforcée aux limites avec les zones à forte incidence.
- **Retrouver les 780 contacts non vus depuis plus de 3 jours** (listes nominatives par aire de santé dans outputs/confidentiel) et renforcer la supervision des relais communautaires.
- **Investigation rétrograde systématique** de chaque nouveau cas sans lien connu (recherche de la source dans les 21 jours précédant les symptômes, funérailles et structures de soins fréquentées).
- **Prélèvement de tous les décès communautaires** et documentation systématique de l'organisateur des funérailles dans la Linelist.

- **Réconcilier le SitRep et la Linelist** chaque semaine par zone de santé (tableau de concordance du tableau de bord).

Messages clés à retenir

• Du 4 oct. au 10 oct. 2026, **344 cas confirmés** et 119 décès ont été notifiés (létalité 34,6 %), contre 392 cas la semaine précédente : tendance **en baisse** (-12 %).
• Suivi des contacts : 1 011 contacts en suivi, **17,3 % vus** le 9 oct. 2026, 780 non vus depuis plus de 3 jours ; seuls **1,0 %** des nouveaux cas étaient connus comme contacts.
• 2 zones en priorité 1 (score ≥ 70) et 15 en priorité 2 (50–69) ; zones les plus prioritaires : Wamba (78), Mambasa (78), Mabalako (69), Musienene (67), Beni (64).

ANNEXE 1 — DÉFINITIONS DE CAS

Cas suspect : toute personne, vivante ou décédée, présentant une fièvre d'apparition brutale et ayant été en contact avec un cas suspect, probable ou confirmé, ou avec un animal mort ou malade ; ou toute personne présentant une fièvre et au moins trois des signes suivants : céphalées, vomissements, anorexie, diarrhée, fatigue intense, douleurs abdominales, douleurs musculaires ou articulaires, difficultés à avaler, difficultés à respirer, hoquet ; ou toute personne présentant des saignements inexpliqués ; ou tout décès inexpliqué.

Cas probable : tout cas suspect évalué par un clinicien, ou tout décès suspect ayant un lien épidémiologique avec un cas confirmé, sans prélèvement possible.

Cas confirmé : tout cas suspect ou probable dont un échantillon est positif au laboratoire (RT-PCR) pour le virus Ebola.

Contact : toute personne ayant été exposée à un cas (contact physique, liquides biologiques, même foyer, soins, funérailles) au cours des 21 jours précédant l'apparition de ses symptômes ; suivie quotidiennement pendant 21 jours après la dernière exposition.

Non-cas : cas suspect dont les résultats de laboratoire sont négatifs.

Définitions adaptées des définitions standard de l'OMS ; se référer au protocole national en vigueur.

ANNEXE 2 — MÉTHODES (RÉSUMÉ)

- Période de rapportage : 7 derniers jours glissants jusqu'à la date des données ; semaines épidémiologiques ISO (lundi–dimanche) pour les tendances.
- Rt : modèle de renouvellement (Cori et al. 2013) sur l'incidence par date de début corrigée des retards de notification ; intervalle sériel estimé sur les paires infecteur–infecté des chaînes reconstituées ; comparaison de 9 méthodes dans le tableau de bord.
- Catégories de zones : grille de la riposte (rouge / orange / jaune / vert / non touchée) ; score de risque 0–100 pondéré (voir méthodologie détaillée).
- Létalité : décès / cas confirmés (cumul) ; la létalité de la période récente est sous-estimée tant que l'issue des cas récents n'est pas connue.
- Méthodologie complète avec formules : document « Méthodologie détaillée » fourni avec l'outil.